

시청 관경 코멘트



월경 이상 문제에서는 제시문에 월경 이상의 종류에 대한 정보가 자세히 주어지지 않을 수 있습니다. 무월경인지, 월경과다인지, 월경통이 심해서 내원한 것인지에 대해 impression을 잡지 못하고 들어갈 수 있음을 유의합니다.

부인과 질환은 공통적으로 산과력과 월경력, 피임 방법에 대한 자세한 문진이 필요합니다. 추가적으로 비뇨기 증세 역시 함께 문진해야 함을 기억해야 합니다. **가족력이 있는 젊은 여성이 무월경을 주소로 온 경우 가장 먼저 조기 폐경을 의심합니다.** 하지만 조기 폐경 증상이 갑상샘항진증의 증상과도 비슷하므로 **갑상샘 이상 유무 역시 확인해야 합니다.**

무월경은 감별 진단이 많으니 체계적으로 외우셔야 합니다. 항상 임신을 배제한 후, 내분비적 이상(갑상샘, Hyperprolactinemia, 쿠싱) 여부를 확인합니다. 속발성의 경우 PCOS와 조기 폐경, 원발성의 경우 터너증후군을 감별해야 합니다. 이 외에도 HPO axis에 영향을 주는 스트레스나 약물 복용력도 잊지 말아야 합니다.

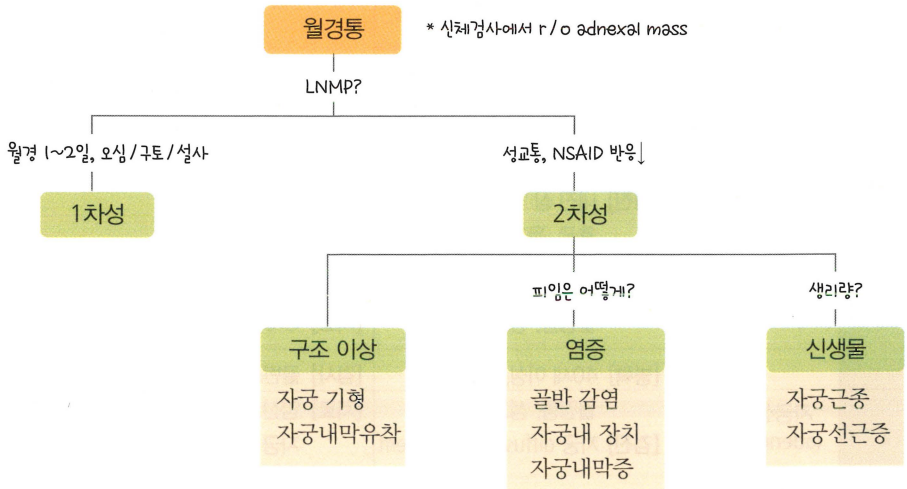
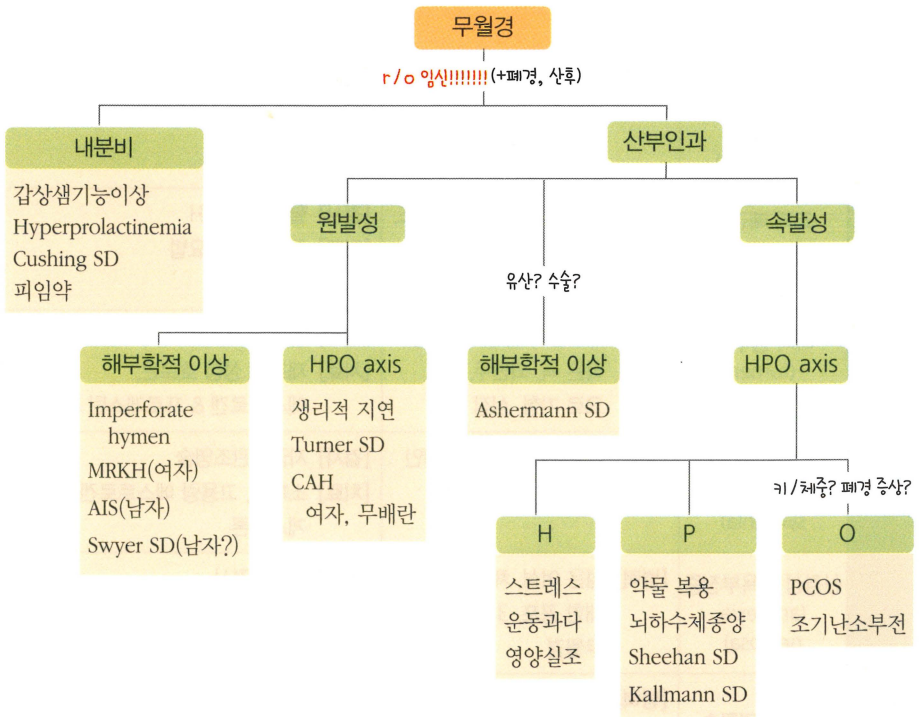
조기 폐경의 경우에는 젊은 여성, 특히 아이가 없는 경우에는 상당한 충격을 줄 수 있으므로 조심스럽게 설명하는 것이 중요합니다. 그러나 갑상샘이나 스트레스성과 같은 다른 가능성도 완전히 배제할 수 없다는 점을 강조하면서 필요한 검사를 설명합니다.

월경통의 경우 병력이 비슷하기 때문에 감별 진단이 어려울 수 있습니다. 하지만, 월경과다가 없으면서 불임을 호소하는 환자에서 자궁내막증을 주요하게 감별할 수 있음을 유의한다면 질환 감별에 도움이 됩니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
무월경	임신	[병력] 피임 안 함, 특별한 증상 없음	[검사] 임신검사 [치료] 임신 교육(산전 진찰편 참조)
	뇌하수체 질환 (prolactinoma, 뇌하수체저하증)	[병력] 무월경, 유즙 분비, 두통, 시야장애	[검사] 혈중 프로락틴 [치료] Bromocriptine, Cabergoline
	쿠싱 증후군 (Cushing syndrome)	[병력] 자색선조, 월면양 얼굴, Buffalo hump, 멍	[검사] 24시간 소변 코티솔 농도, Dexamethasone suppression test [치료] 부신절제술, 경첩형동생증절제술

무월경	갑상샘항진증 (hyperthyroidism)	[병력] 만성 피로, 더위불내성, 체중 감소, 희발월경	[검사] 갑상샘 호르몬검사 [치료] 항갑상샘 약제(Propylthiouracil, Methimazole)
	다낭난소증후군★ (polycystic ovarian syndrome)	[병력] 다모증, 여드름, 체중 증가, 무월경~과다월경	[검사] 골반초음파, serum FSH/LH [치료] 체중 감량, 임신 원할 시 클로미펜, 메트포민
	조기 폐경★ (premature menopause)	[병력] 이차성 무월경, 안면홍조, 화끈거림, 땀, 열감, 두근거림, 불안, 불면증	[검사] 혈중 FSH/LH [치료] 호르몬 대체요법
	터너 증후군 (turner syndrome)	[병력] 원발성 무월경, 작은키, 작은 턱, 외반주, 요로 기형, 심장 기형	[검사] 혈중 FSH/LH [치료] 재조합 성장 호르몬, 에스트로겐 & 프로게스테인 공급
	자궁내막유착증 (intrauterine synechia)	[병력] 자궁소파술이 주된 원인	[검사] 자궁난관조영술 [치료] 소파술, 고용량 에스트로겐+프로게스테론
	신경성 식욕부진증 (anorexia nervosa)	[병력] 젊은 여성, 체중 증가에 대한 공포, 3회 이상 무월경	[검사] 전해질검사 [치료] 입원 치료, 영양 공급, 정신 치료, SSRI
월경통	원발 월경통★ (primary dysmenorrhea)	[병력] 초경 후 1~2년/월경 시작 후 48~72시간 지속 월경통, 오심, 구토 [검진] 하복부 압통	[검사] 임상적 진단 [치료] 진통제, 운동, 필요 시 경구피임제
	자궁내막증★ (endometriosis)	[병력] 25~35세, Triad : 불임, 월경통, 성교통/월경과다 없음 [검진] 내진 상 결정, 자궁이 후굴, 운동성 감소	[검사] 자궁난관조영술, 혈중 CA-125, 골반초음파, 진단적 복강경 [치료] 복강경하 수술, 프로게스테인, 다나졸 등
	자궁근종★ (uterine myoma)	[병력] 30~45세, 월경과다, 월경통, 성교통	[검사] 골반초음파, 자궁난관조영술 [치료] GnRH agonist, 자궁근종절제술
	자궁생근육증 (adenomyosis)	[병력] 40세 이상, 월경과다, 월경통, 성교통 [검진] 자궁 diffuse enlargement	[검사] 골반초음파 [치료] 임신 원할 경우 진통제, 피임제, 자궁 내 장치, 원하지 않으면 자궁절제술



STEP 1 병력 청취

무월경

먼저 오늘 문진 내용은 제가 기록은 하지만 타인은 볼 수 없고, 비밀이 유지되므로 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다. 몇 가지 질문해도 될까요?

O	생리를 얼마 동안 하지 않으셨나요?
L	-
D	-
Co	-
Ex	이전에도 이렇게 생리를 거르신 적이 있나요? → 치료는?
C = 여	[월경력] 평소에는 월경 주기가 몇 일이었나요?/규칙적이었나요? LNMP/임신 가능성/월경 기간은 몇 일이었나요? 월경량은 적당했나요?/월경통이 심하신 편이었나요? [산과력] 결혼은 하셨나요?/아이는 몇 명 있으신가요? 자연분만이었나요, 제왕절개였나요? 혹시라도 유산의 경험은 없으신가요? → (최근 출산 시) 수유 중이신가요?/출산할 때 출혈이 많았나요? 암기법 TPLA + 수유/출혈 [성관계] 마지막 성관계는 언제인가요?/성교통이 있으신가요? 피임은 하시나요?/피임 방법은 어떻게 될까요? [초경] 초경은 언제하셨나요?
A	[소화기] 구역/구토/변비/설사/통증 [비뇨기] 빈뇨/절박뇨/야간뇨/배뇨통 [전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [응급] 어지럼/호흡곤란이 있으신가요? (자궁 외 임신) [터너] 토래와 비슷한 시기에 2차 성징(가슴, 음모)이 있었나요? (난소) 목 모양, 팔 굽이 확인/지금 현재 키와 체중이 어떻게 되나요? [Prolactinoma] 두통/시야장애가 있었나요?/젖이 맺히거나 흐르나요? (머리) [쿠싱] 배에 보라색 선이 생겼나요? (내분비) 암기법 저는(전능) 난소나 머리에 내분이 일어났나 봐요.

A	[갑상샘] 더위불내성/두근거림이 있었나요?
	[PCOS] 몸에 털이나 여드름이 많은가요?
	[조기 폐경] 식은땀/안면홍조/야간 발한/불면증이 있나요?
	[정신] 우울/불안감이 있으신가요? 본인 체형에 대해 어떻게 생각하고 계세요? (신경성 식욕부진증)
F	[운동] 최근 운동을 삼하게 하셨나요? 식단 관리 중이신가요?
E	[건강 검진] 이전 건강 검진에서 pap test 같은 산부인과 검진도 받으셨나요?
외	[외상] 복부에 외상을 입으시거나 어디 부딪히신 적 있나요? [수술] 산부인과 수술이나 시술을 받은 적 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요?(정신건강의학과 약, 항도파민 약물) (항도파민약물이라고 하면 SP가 되물을 가능성이 높을 것 같아 정신건강의학과 약 옆에 추가하는 것이 좋을 것 같습니다)
사	술, 담배, 커피는 하시나요? 직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스가 최근 심하셨나요? [BMI] 키와 체중이 어떻게 되시나요?
가	가족 중에 유사 증상을 가진 분이 계신가요? (어머니 조기 폐경)
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 신체 검진을 위해서는 불가피하게 골반 아래쪽 노출이 필요합니다. [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) ⊕ Prolactinoma 의심 시 시야검사 시행 2. 입 : 구강 점막 3. 목* : 갑상샘 촉진 ⊕ 터너 증후군 의심 시 상의 탈의 후 유방 발달 확인 [누워서] 4. 복부 진찰* : 시-청-타-촉 5. 전신 피부 : 다모증, 여드름 6. 사지 : 피부 긴장도

술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 산부인과 진찰 : 자궁경부퍼바름검사, 질분비물검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?
----	---

월경통

☞ 먼저 오늘 문진 내용은 제가 기록은 하지만 타인은 볼 수 없고, 비밀이 유지되므로 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다. 몇 가지 질문해도 될까요?

O	언제부터 아프셨나요? 초경 이후 계속 있었나요?
L	통증 부위를 짚어 주시겠어요?
D	생리 때마다 아프신 건가요? 월경 주기 중 몇 일부터 몇 일까지 아프신가요?
Co	점점 심해지시나요?
Ex	이전에도 이런 증상이 나타난 적이 있나요? → 진통제 효과?/치료는?
C = 여	[양상] 통증 양상은 어떤가요? (쿵쿵 쑤시듯이/바늘로 찌르듯이/둔하게) + NRS [정도] 안 아픈 것을 0점 가장 아픈 것을 10점이라고 했을 때 몇 점 정도인가요? [월경력] 평소 월경 주기가 어떻게 되시나요?/규칙적인가요?/LMP/임신 가능성 월경 기간은 몇 일 정도되나요? 월경량은 적당한가요? (패드 몇 장? → 월경 과다 시 자궁근종, 자궁생근육증 가능성) [초경] 초경은 언제하셨나요? [성관계] 마지막 성관계는 언제인가요?/성관계 시 통증이 있나요? (자궁내막증, 자궁근종) 모든 분들께 여쭙보는 질문이니 당황하지 마시고 혹시 평소에 성관계는 남편과만 하시나요? [산과력] 결혼은 하셨나요?/아이가 있으신가요? or 임신을 원하는데 임신이 잘 안 되나요? 혹시나 유산의 경험이 있으신가요? (최근 출산 시) 수유 중이신가요?/출산할 때 출혈이 많았나요? 임기법 TPLA + 수유/출혈 [피임] 피임은 어떻게 하시나요?

A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [일차성 월경통] 하복부 압통(A)/오심(N)/구토(V)/설사(D) → ANVD [Mass Effect] F/U/N/D, 잔뇨감/변비/복부에 만져지는 덩어리 [탈수] 어지럼증/두근거림 → 두어목 호소 암기법 월경통이 전일 있어 M자 탈모 걸릴듯
F	최근 운동을 심하게 하셨나요?
E	[건강 검진] 이전 건강 검진에서 pap test 같은 산부인과 검진도 받으셨나요?
외	[외상] 복부에 외상을 입으시거나 어디 부딪하신 적 있나요? [수술] 산부인과 수술이나 시술을 받은 적 있나요? (자궁 내 장치, 자궁소파술)
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (산부인과 질환, 골반 내 감염, 방광염)
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (피임약, 정신건강의학과 약)
사	술, 담배, 커피는 하시나요? 직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스를 최근 많이 받으셨나요?
가	가족 중에 유사 증상을 가진 분이 계신가요? (산부인과 질환, 월경통)
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 신체 검진을 위해서는 불가피하게 골반 아래쪽 노출이 필요합니다. 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) 2. 입 : 구강 점막 [누워서] 3. 복부 진찰*: 시-청-타-촉 4. 사지 : 피부 긴장도
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 산부인과 진찰 : 자궁경부파파름검사, 질분비물검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

	무월경	월경통
공감	그 동안 월경이 불규칙하여 걱정도 되고 많이 놀라셨겠습니다.	그 동안 월경통이 심하여 걱정도 되고 많이 힘들었습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 여드름과 털이 많은 증상으로 미루어 보아 다낭난소증후군이 가장 의심됩니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 월경과다와 함께 복부에 덩어리가 만져지는 것으로 미루어 보아 자궁근종이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 무월경에는 조기 폐경이나 정상 임신 등 다양한 원인이 있을 수 있습니다.	하지만 월경통을 일으키는 다른 질환으로 자궁섬근육종 등 다양한 질환이 있을 수 있습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 혈액검사, 골반초음파검사, 소변임신검사가 필요합니다. 괜찮으신가요?	따라서 정확한 진단을 위해서는 골반초음파검사, 자궁난관조영술, 골반 MRI가 필요합니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사 후에도 다낭난소증후군으로 진단이 되면 규칙적인 월경을 위해 경구피임약을 꾸준히 복용해 주셔야 합니다. 나중에 임신을 원하시게 될 경우 배란유도제를 복용하면 높은 확률로 임신이 가능하므로 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.	만약 검사 후에도 자궁근종으로 진단이 되면 환자분께서 증상이 심하고 많은 불편을 호소하시기 때문에 수술이 필요할 수 있습니다. 수술 전 증상 호전을 위해서 단기간 약물 치료를 시행해 볼 수 있겠습니다.
예후	지금부터 꾸준히 치료를 받으시면 좋아지실 것입니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.	지금부터 치료를 받으시면 좋아지실 것입니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[생활 습관 개선] 하지만 무엇보다 이 질환으로 인한 부작용을 줄이기 위해서는 체중 감량이 필수입니다. 조금이라도 몸무게를 빠시면 당뇨나 심혈관계 질환 등의 위험성을 줄일 수 있습니다. [약 복용법] 경구피임약 등을 복용하실 때에는 복용법에 맞게 복용하셔야 부작용으로 자궁 출혈이 생기지 않을 수 있습니다.	[응급] 생리량 과다로 호흡곤란 발생 시에는 수액 정주 등 응급 치료가 필요함을 설명 [정기 검진 권유] 별다른 문제가 없더라도 정기적으로 산부인과 검진을 받는 것을 권고드립니다.

교육	[과격한 운동 제한] 갑자기 과격한 운동을 시작하실 경우에도 월경 주기에 이상이 생길 수 있습니다. [정기 검진 권유] 별다른 문제가 없더라도 정기적으로 산부인과 검진을 받는 것을 권고드립니다.	
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?	

무월경

❖ 기본적 진단 계획

- ① Prolactinoma : 혈중 prolactin
- ② 쿠싱 증후군 : 24시간 소변 코티솔 농도, Dexamethasone suppression test
- ③ 갑상샘항진증 : 갑상샘 호르몬검사
- ④ 다낭난소증후군 : 골반초음파
- ⑤ 조기 폐경 : 혈중 FSH/LH

❖ 치료 계획

- ① Prolactinoma : bromocriptine, cabergoline
- ② 쿠싱 증후군 : 부신절제술, 경첩형동 샘종절제술
- ③ 갑상샘과다증 : 항갑상샘 약제
- ④ 다낭난소증후군 : 체중 감량, 임신 소망 시 클로미펜, 메트포민
- ⑤ 조기 폐경 : 호르몬 대체요법

❖ 진단 계획

- ① 원발 월경통 : 임상적 진단
- ② 자궁내막증 : 자궁난관조영술, 혈중 CA-125, 복강경 수술을 통한 조직학적 검사
- ③ 자궁근종 : 골반초음파, 자궁난관조영술
- ④ 자궁샘근육증 : 골반초음파

❖ 치료 계획

- ① 원발 월경통 : 진통제, 운동, 필요 시 경구피임제
- ② 자궁내막증 : 복강경 수술, 프로게스틴, 다나졸
- ③ 자궁근종 : GnRH agonist, 자궁근종절제술
- ④ 자궁샘근육증 : 임신 원할 경우 진통제, 피임제, 자궁 내 장치, 원하지 않으면 자궁 절제술

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 내분비적 문제가 의심되는 경우 혈중 호르몬검사가 필요하며, 약물 치료를 통해 교정이 가능함을 설명
- ② 스트레스나 과도한 운동에 의해서 발생하는 경우 자제시킬 것
- ③ 생리량 과다로 호흡곤란 발생 시에는 수액 정주 등 응급 치료가 필요함을 설명
- ④ 자궁 내 문제가 의심되는 경우는 질초음파를 시행하고, 약물 치료 및 필요 시 수술적 치료도 가능함을 설명



keyword

산과력과 월경력, 피임 방법 문진하기

무월경 : 임신, 내분비 이상, 속발성(PCOS, 조기 폐경)/원발성(터너증후군)

조기 폐경 : 의사-환자 관계에 신경써서 말하기

월경과다 교육 : 응급 상황 교육

공통 교육 : 정기적 산부인과 검진